Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara Judicial da Comarca de Espumoso

Rua Independência, 212 - Bairro: São Jorge - CEP: 99400-000 - Fone: (54) 3046-9882 - WhatsApp (54) 9712-5167 - Email: frespumosovjud@tjrs.jus.br

AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5002110-15.2022.8.21.0046/RS

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AUTOR: LONI ANA ROTTA
RÉU: MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE / RS
RÉU: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

I. RELATÓRIO

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL** ajuizou a presente **AÇÃO CIVIL PÚBLICA**, com pedido de tutela de urgência, em favor da idosa **LONI ANA ROTTA**, em face do **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL** e do **MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RS (evento 1, INIC1)**. Narrou que a favorecida, Sra. Loni Ana Rotta, com 67 anos de idade à época, foi diagnosticada como portadora de Síndrome Mielodisplásica, patologia classificada sob o CID D46. Disse que em decorrência de tal enfermidade, foi-lhe prescrito o uso contínuo e diário do medicamento ELTROMBOPAGUE 50mg. Sustentou que o fármaco não foi disponibilizado administrativamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sob o argumento de não integrar as listas de dispensação gratuita. Aduziu, ainda, a hipossuficiência financeira da paciente e de seu núcleo familiar para arcar com o elevado custo do tratamento, estimado em aproximadamente R$ 10.400,00 mensais, uma vez que a favorecida e seu cônjuge percebem, cada um, aposentadoria no valor de um salário mínimo. Destacou a gravidade da condição clínica da paciente, com risco iminente de evolução para leucemia, caso o tratamento não fosse iniciado. Fundamentou a pretensão nos artigos 196, 198, 227 e 230 da Constituição Federal, bem como nos artigos 3º, 15 e 74 do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03), pleiteando, em sede de tutela de urgência, a imediata determinação para que os entes demandados fornecessem o medicamento, sob pena de bloqueio de valores. Ao final, pugnou pela confirmação da medida liminar, com a procedência do pedido principal. Juntou documentos.

Através da decisão proferida no evento 3, DESPADEC1, foi deferida a tutela de urgência pleiteada, determinando-se aos réus o fornecimento do medicamento ELTROMBOPAGUE 50mg à favorecida, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de bloqueio de valores.

Citado, o **MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RS** apresentou contestação no evento 19, CONT1. Em sede preliminar, arguiu a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, com base no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, sustentando que o financiamento do fármaco, por pertencer ao Grupo 1B da assistência farmacêutica, seria de responsabilidade do ente federal. No mérito, defendeu a improcedência do pedido, alegando a ausência de comprovação da ineficácia das alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS, em dissonância com os requisitos do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, e invocou o princípio da reserva do possível.

O **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**, por sua vez, contestou a ação no evento 25, CONT1, alinhando-se à tese preliminar de litisconsórcio passivo necessário com a União, com base nas regras de repartição de competências do SUS e no Tema 793 do STF. No mérito, reiterou a necessidade de observância estrita dos critérios estabelecidos pelo STJ no Tema 106 para o fornecimento de medicamentos não padronizados, argumentou sobre o alto custo do tratamento e a impossibilidade de o Estado ser compelido a fornecer prestações de saúde não previstas nas políticas públicas.

O Ministério Público apresentou réplica às contestações nos evento 22, CONTRAZ1 e evento 28, RÉPLICA1, rechaçando as preliminares e insistindo na responsabilidade solidária dos entes demandados e na imperiosidade da proteção ao direito à saúde da favorecida.

No curso do processo, iniciou-se controvérsia jurisdicional. Em decorrência do Agravo de Instrumento nº 5240232-09.2022.8.21.7000, interposto pelo Município, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reconheceu o litisconsórcio passivo necessário da União, o que levou este Juízo a determinar a emenda da inicial (evento 34, DESPADEC1). O Ministério Público aditou a petição para incluir a União (evento 37, PROMOÇÃO1), e os autos foram remetidos à Justiça Federal (evento 39, DESPADEC1).

Contudo, a 1ª Vara Federal de Carazinho, em decisão proferida no evento 62, DESPADEC1, declinou da competência e devolveu os autos a esta Justiça Estadual, fundamentando sua decisão em recentes entendimentos do STJ (IAC 14) e do STF (Tema 1234), que, para os casos de medicamentos não incorporados, estabeleceram a competência do juízo ao qual a ação foi originalmente direcionada.

Retornando os autos a esta comarca, e diante do descumprimento da medida liminar, foi efetuado o bloqueio de valores nas contas dos entes públicos para a aquisição do medicamento (evento 67, DESPADEC1), com a devida prestação de contas homologada no evento 101, DESPADEC1.

Posteriormente, proferida sentença de procedência (evento 111, SENT1), esta foi desconstituída em sede de apelação (Processo 5002110-15.2022.8.21.0046/TJRS, Evento 17, DECMONO1), com nova determinação de remessa dos autos à Justiça Federal. Após nova emenda da inicial pelo Ministério Público (evento 132, PROMOÇÃO1), os autos foram novamente encaminhados ao juízo federal.

Em nova manifestação, o 2º Núcleo de Justiça 4.0 RS da Justiça Federal, em decisão fundamentada (evento 167, DESPADEC1), reconheceu a ilegitimidade passiva da União para o caso concreto e, mais uma vez, determinou a devolução dos autos a esta Vara Judicial, pacificando a questão da competência.

Estabilizada a competência neste Juízo Estadual, foi proferida decisão interlocutória no evento 175, DESPADEC1, determinando à parte autora a adequação da petição inicial e a juntada de documentos para atender às diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1234, especialmente no que tange à comprovação da eficácia do tratamento por meio de evidências científicas de alto nível. Na mesma oportunidade, foi solicitada a elaboração de nota técnica ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (e-NatJus).

A **Nota Técnica nº 305841** foi juntada ao evento 190, NOTATEC1, apresentando parecer *não favorável* ao fornecimento do medicamento, ressaltando a ausência de liberação para a indicação solicitada (Síndrome Mielodisplásica) e a carência de laudos confirmatórios do diagnóstico, como Mielograma ou biópsia de medula óssea.

Em resposta à intimação, a parte autora juntou novos documentos médicos, incluindo laudos de exames (evento 191, PET1, evento 218, PET1 e evento 221, PET1), buscando suprir as lacunas apontadas. Em manifestação (evento 202, PROM1), o Ministério Público argumentou pela prevalência do laudo do médico assistente sobre o parecer técnico.

Intimados, os réus se manifestaram. O Estado do Rio Grande do Sul (evento 204, PET1) requereu a intimação da parte autora para juntar documentação complementar e a realização de nova nota técnica.

Diante da juntada dos novos exames, foi solicitada nota técnica complementar. A **Nota Técnica nº 367499** foi acostada no evento 223, NOTATEC1. Embora reconhecendo a melhora na documentação diagnóstica, o parecer manteve a conclusão *não favorável*, sob o fundamento de que *"já existem estudos randomizados com uso de eltrombopage com azacitidina que não mostraram benefício da medicação"*, concluindo que "*NÃO há elementos técnicos para sustentar a indicação da medicação solicitada (ELTROMBOPAGE), no presente caso".*

Instadas a se manifestarem sobre o novo parecer e a indicarem outras provas a produzir, as partes reiteraram suas posições anteriores, com os réus pugnando pela improcedência com base nas notas técnicas (evento 228, PET1 e evento 230, PET1) e o Ministério Público insistindo na procedência do pedido (evento 232, PROM1), declarando não haver mais provas a produzir.

É o relatório. Decido.

II. FUNDAMENTAÇÃO

II.1. DAS PRELIMINARES

Sinalo, de início, que não existem questões preliminares pendemtes de apreciação, razão pela qual passo, de logo, à análise do mérito.

II.2. DO MÉRITO

<u>Do direito à saúde.</u>

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, *caput*, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, garantiu o direito à vida e em seu artigo 6º, *caput,* que cuida dos direitos sociais, assegurou o direito à saúde, dentre outros. Não bastasse isso, o artigo 196, que trata da ordem social, prescreveu o direito à saúde e o dever do Estado. A Lei 8.080/90, em seu artigo 2º, reiterou que a saúde é um direito fundamental do cidadão, incumbindo ao Estado prover as condições ao seu pleno exercício, disciplinando o SUS – Sistema Único de Saúde -, e incumbindo aos entes públicos a prestação de serviços de saúde à população.

A Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, no mesmo sentido, em seu artigo 241, preceitua que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado e do Município, a ser ofertada através de sua promoção, proteção e recuperação.

O acesso à saúde é direito fundamental e as políticas públicas que o concretizam devem gerar proteção suficiente ao direito garantido, sendo passíveis de revisão judicial, sem que isso implique ofensa aos princípios da divisão de poderes, da reserva do possível ou da isonomia e impessoalidade. Nesse sentido a Apelação Cível nº 70050003987, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 31/07/2012.

<u>Do tratamento postulado.</u>

No caso em análise, a controvérsia reside na obrigatoriedade de o poder público fornecer o medicamento **ELTROMBOPAGUE 50mg (REVOLADE®)**, não incorporada ao SUS para a patologia que acomete a autora.

A matéria foi recentemente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas de Repercussão Geral n.º 6 (RE 566.471) e n.º 1234 (RE 1.366.243), cujas teses devem ser obrigatoriamente observadas.

O Tema 6 do STF estabeleceu que a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS é excepcional e exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe à parte autora:

> *(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;*
>
> *(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;*
>
> *(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;*

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

Adicionalmente, o Tema 1234 do STF determinou que o Poder Judiciário, sob pena de nulidade, deve obrigatoriamente analisar o ato administrativo da CONITEC que resultou na não incorporação, bem como a negativa administrativa de fornecimento, restringindo-se ao controle de legalidade, sem incursionar no mérito administrativo.

No presente caso, a parte autora busca o fornecimento do medicamento **ELTROMBOPAGUE 50mg (REVOLADE®).**

Todavia, todos os requisitos NÃO estão devidamente preenchidos.

Não se olvida que a conveniência do tratamento médico específico, com uso de determinado tratamento/substância ou dosagem, é de competência exclusiva daquele profissional que acompanha o enfermo (Resolução n. 1.246, de 8.1.88, do Conselho Federal de Medicina, Código de Ética Profissional e incs. V e VIII do Cap. 1 da Res. Do Conselho Federal de Medicina n. 1931/2009).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR NA MODALIDADE "HOME CARE". DEMANDANTE PORTADOR DE DOENÇA DE MACHADO-JOSEPH -CID 10-G 11-2 E NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA- CID10- C 50.9. INAPLICABILIDADDE DO TEMA 793 DO STF AO CASO CONCRETO. JULGAMENTO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA NO STJ. NOTA TÉCNICA ELABORADA PELO CNJ QUE NÃO PODE SE SOBREPOR AO LAUDO MÉDICO. PERÍODO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO AMPLIADO. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA. *1. De plano, há de se destacar que a questão atinente à aplicabilidade do **Tema** 793 do STF, na presente demanda, já foi superada, em razão do julgamento do Conflito de Competência nº 188071 - RS (2022/0131062-6), julgado em 12 de maio de 2022, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, tendo determinado a competência da Justiça Estadual para processamento e julgamento do presente feito. 2. A inconformidade recursal diz respeito unicamente à limitação de horário ao atendimento de técnico em enfermagem disponibilizado, limitado a 2 horas por dia, na decisão recorrida, quando seu médico assistente recomendou que esse atendimento fosse de, no mínimo, 12 horas diárias. **Nota técnica elaborada pelo CNJ que não pode se sobrepor à recomendação do médico assistente da parte, pois é ele que conhece melhor a paciente e possui melhor capacidade técnica de prescrever o tratamento à paciente**. 3. Hipótese em que o atestado médico do profissional, devidamente habilitado, que acompanha o tratamento da parte autora constitui prova suficiente para embasar sua pretensão, bem como a adequação do tratamento prescrito para a doença que a acomete. Laudo emitido pelo médico que indica a necessidade de acompanhamento pelo período de 12 horas diárias, diferente do que foi concedido em juízo a quo. Presentes os requisitos no art. 300 do CPC, há de se acolher integralmente a pretensão recursal. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento, Nº 52104029520228217000, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 09-02-2023)*

De igual forma, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que ***"a escolha do medicamento compete a médico habilitado e conhecedor do quadro clínico do paciente, podendo ser tanto um profissional particular quanto um da rede pública"*** (REsp 1.794.059/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.4.2019).

De fato, o médico que acompanha o quadro clínico da parte autora e conhece suas peculiaridades prescreve o tratamento que reputa mais adequado, devendo tal prescrição preponderar sobre eventual parecer administrativo genérico e abstrato.

Todavia, a Nota Técnica do E-NatJus (evento 190, NOTATEC1) concluiu que: *"CONCLUI-SE que NÃO há elementos técnicos para sustentar a indicação da medicação solicitada (ELTROMBOPAGE), no presente caso em caráter de urgência"*

Veja-se o desenvolvimento desta conclusão:

Tecnologia: ELTROMBOPAGUE OLAMINA

Conclusão Justificada: Não favorável

Conclusão: CONSIDERANDO o diagnóstico de Síndrome Mielodisplásica conforme relatórios médicos acostados ao processo

CONSIDERANDO que a medicação eltrombopage não foi liberada para tratamento para a indicação solicitada.

CONSIDERANDO a ausência de laudos de Mielograma ou biópsia de medula óssea que confirme o diagnóstico da paciente

Página 3 de 4

CONCLUI-SE que NÃO há elementos técnicos para sustentar a indicação da medicação solicitada (ELTROMBOPAGE), no presente caso em caráter de urgência.

Há evidências científicas? Sim

Após a juntada de novos exames pela parte autora, que buscaram sanar a deficiência diagnóstica, foi elaborada uma nova e mais aprofundada análise, a **Nota Técnica nº 367499** (evento 223, NOTATEC1). Esta segunda nota, mesmo diante dos exames complementares, manteve a conclusão *não favorável*, com fundamentos ainda mais contundentes. O parecer técnico esclarece, no campo "*Evidências sobre a eficácia e segurança da tecnologia"*, que:

> *"A utilização da medicação eltrombopag já foi testada em associação com agentes hipometilantes em estudos randomizados, porém não mostrou benefícios."*

E, ao final, conclui de forma categórica:

> *"CONSIDERANDO que já existem estudos randomizados com uso de eltrombopage com azacitidina que não mostraram benefício da medicação CONCLUI-SE que NÃO há elementos técnicos para sustentar a indicação da medicação solicitada (ELTROMBOPAGE), no presente caso em caráter de urgência."*

Ademais, ao ser questionado se *"Há evidências científicas?",* o parecerista respondeu com um taxativo *"Não".*

Tais conclusões, emanadas de um órgão técnico e desinteressado, com base em referências bibliográficas científicas e na análise de estudos clínicos, demonstram de forma inequívoca que a pretensão da parte autora carece de fundamento científico. O medicamento postulado, para a patologia específica da Sra. Loni Ana Rotta, não possui eficácia comprovada por evidências de alto nível, sendo, para essa finalidade, um tratamento experimental.

A insistência do Ministério Público na prevalência da opinião do médico assistente (evento 202, PROM1 e evento 232, PROM1) não pode prosperar. Conforme já delineado, a decisão judicial em matéria de saúde, especialmente em se tratando de tecnologias não incorporadas, não pode ser um ato de mera homologação de prescrições médicas individuais. Deve, ao contrário, ser um ato de controle da legalidade e de ponderação de princípios, fundamentado em critérios objetivos e técnicos. Deferir o pedido nestas circunstâncias significaria substituir a discricionariedade técnica da administração pública, baseada em evidências, pela convicção isolada de um profissional, por mais bem-intencionada que seja.

Portanto, diante da ausência de comprovação de um dos requisitos essenciais e cumulativos para a concessão judicial de medicamento não incorporado – qual seja, a demonstração de eficácia e segurança do tratamento com base em evidências científicas de alto nível –, a improcedência do pedido é medida que se impõe. Obrigar os entes públicos a custear um tratamento de valor expressivo, sem respaldo científico para a indicação pretendida, representaria uma alocação ineficiente de recursos públicos escassos, em detrimento de outras políticas de saúde de eficácia comprovada e de alcance universal, violando os princípios da isonomia, da eficiência administrativa e da própria lógica que rege o Sistema Único de Saúde.

III. DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, **JULGO IMPROCEDENTE** o pedido efetuado por **LONI ANA ROTTA** em face do **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e do MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RS,** revogando a tutela de urgência concedida no evento 3, DESPADEC1.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, por força do artigo 18 da Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública).

Sentença publicada eletronicamente. Intimação eletrônica.

Em sendo opostos embargos de declaração, dê-se vista deles à parte embargada, para que, querendo, exerça o contraditório, em cinco dias (artigo 1.023, § 2°, do CPC). Após, voltem para julgamento.

Considerando que o §3º, do art. 1.010, do CPC retirou o juízo de admissibilidade deste 1º grau de jurisdição, uma vez interposto recurso de apelação, caberá ao Cartório abrir vista à parte contrária para contrarrazões, no prazo de 15 dias, consoante art. 1.010, §1º, do CPC.

Idêntico procedimento deverá ser adotado na hipótese de recurso adesivo, conforme §2º do artigo supramencionado.

Documento assinado eletronicamente por **NÚBIA DE MIRANDA FRIÁS, Juíza de Direito**, em 13/01/2026, às 19:26:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10098210366v26** e o código CRC **cdcc208b**.